EXAMEN PRIMAIRE

Version : 20/10/2019

eXsanguination :

- Identifier et traiter les menaces vitales :
  - Hémorragies

Airway : *voies respiratoires*

- Notion de Traumatisme => Stabilisation manuelle du rachis (Maintien Tête)
- Libération des Voies Aériennes (V.A)
  - L.V.A. Classique
  - Élévation du menton seul => si Traumatisé
  - Désobstruction V.A. : Aspiration de mucosités (si obstruction par liquide biologique)

Breathing : *Évaluer la respiration*

- Dénuder le thorax afin de regarder et palper :
  - Symétrie des mouvements respiratoires
  - Efforts respiratoires - Cyanose
  - Tirage
  - Trace de contusion, déformation ou plaie du thorax
  - Emphysème sous cutané
- 1ère impression sur la qualité de la respiration : *(**F**réquence – **A**mplitude – **S**ymétrie)*
  - **F** : Rapide – Lente - Pause.
  - **A** : Superficielle - Profonde.
  - **S** : Symétrique – Volet costal.
- Mesure de la SpO^2 : Mise sous O^2 suivant objectif de saturation ou si non fiabilité oxymètre / anomalie de la respiration.

Objectifs de saturation	SpO^2 de 94 à 98 % chez l'adulte et en pédiatrique SpO^2 de 89 à 92 % chez l'IRC / BPCO

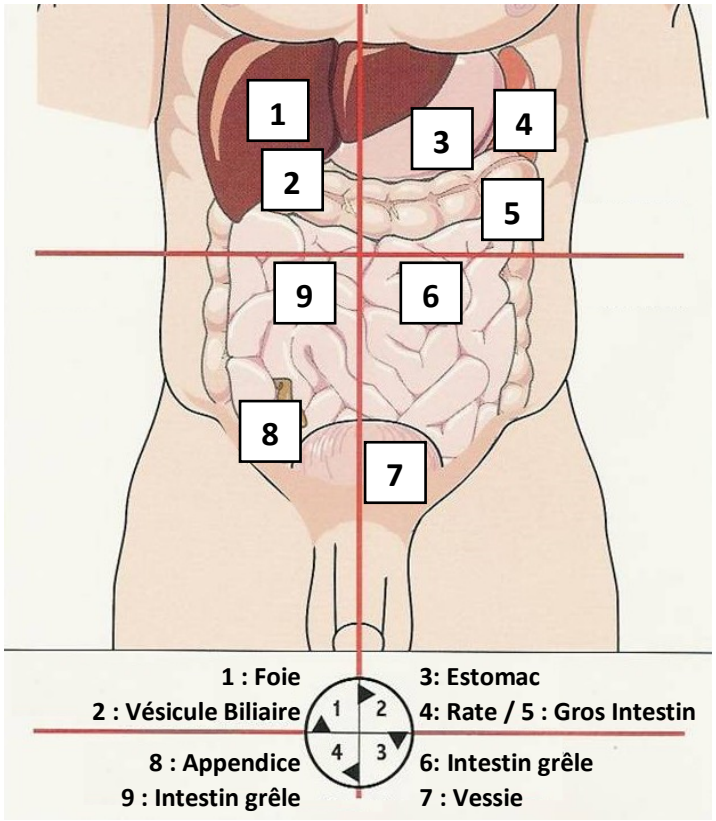
	M.H.C *Adulte et Pédiatrique*	Masque simple *Adulte et Pédiatrique*	Lunettes à O^2
Débit initial	15 l/min	10 l/min	2 l/min *(1 à 2 l/min de + / débit habituel)*
Plage de réglage	8 à 15 l/min	6 à 10 l/min	1 à 6 l/min

Circulation : *Évaluer la circulation*

- Pouls radial :
  - Présent – Filant – Absent
  - Régulier – Irrégulier
  - Rapide – Lent
- Pouls radial présent = Pression Artérielle Systolique *(P.A.S)* > 80mmHg
  - Si pouls radial absent = P.A.S < 80mmHg et vérifier la présence du pouls carotidien.
- Temps de Recoloration Cutanée
- État de la peau : Température et couleur
- Présence de sueurs

Circulation : *Évaluer la circulation (Suite)*

- Suspicion Hémorragie si :
  - Absence du pouls radial et présence d'un pouls central (carotidien – fémoral).
  - Modification du pouls (rapide et superficiel).
  - T.R.C. > à 3 secondes.
  - Pâleur – Moiteur.
  - <u>Notion de traumatisme.</u>
- Observation et Palpation des régions anatomiques des boites à sang = *Blood box*
  - Thorax : instabilité, asymétrie, volet costal, plaie perforante…
  - 4 Quadrants de l'abdomen : défense, contusion, plaies, douleurs, éviscération…
  - 2 fémurs : douleurs, déformation, instabilité…



Corps humain = 4,5 à 6 litres de sang.

<u>Perte moyenne / os fracturé :</u>

Côtes : 125 ml
Radius / Cubitus : 250 à 500 ml
Humérus : 500 à 750 ml
Tibia : 500 à 1000 ml
Fémur : 1000 à 2000 ml
Bassin : 500 à 5000 ml

<u>Rappel :</u>

Importance de lutter contre l'hypothermie :

- 1°C de température corporelle = - 10 % de coagulation en moins….

Moins de coagulation ➔ Plus de saignement ➔ Plus de remplissages ➔ Majoration de l'hypothermie, dilution des facteurs de coagulation….

- Rechercher **<u>SANS PALPER</u>** une plainte au niveau du bassin

Disability : *Évaluer l'état neurologique*

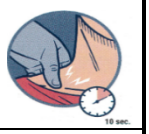
- Score de GLASGOW (15)
  - Réponse Oculaire (Y / 4)
  - Réponse Verbale (V / 5)
  - Réponse Motrice (M / 6)
- Examen des Pupilles : Symétrie et Réactivité
  - P.E.R.R.L. (Pupilles Égales Rondes et Réactives à la Lumière)
- Motricité et sensibilité des 4 membres.

Demander à la victime d'ouvrir les 2 yeux ou ouvrir les yeux de la victime pour les mettre à la lumière « du jour ».
La constatation de pupilles de diamètres différents doit faire considérer la victime en ***détresse neurologique.***

Exposition : *Exposer le patient et le protéger*

- Observer les lésions de la victime traumatisée en respectant sa pudeur.
- Couvrir systématiquement la victime + poche de chaud si nécessaire.

Score de Glasgow (15)

Réponse Oculaire (Y)	Score
SPONTANÉE : Yeux ouverts ou ouverture spontanée des yeux	4
À LA DEMANDE : Ouverture à l'appel au bruit ou quand on le demande	3
A LA DOULEUR : Ouverture des yeux provoquée après pression d'un ongle	2
ABSENTE : Pas d'ouverture des yeux	1
Réponse Verbale (V)	**Score**
NORMALE : Bien orientée dans le temps et dans l'espace. *Ex : Nom, date et lieu…* *(Pédiatrique : Mots appropriés, sourit, fixe, suit du regard)*	5
CONFUSE : La conversation est possible mais confuse ou désorientée *(Pédiatrique : Mots appropriés, pleure, consolable)*	4
INAPPROPRIÉE : Elle ne prononce que des mots isolés, propos incohérents *(Pédiatrique : Hurle, inconsolable)*	3
INCOMPRÉHENSIBLE : La victime émet que des gémissements ou des grognements. *(Pédiatrique : Gémit aux stimuli douloureux)*	2
ABSENTE : Pas de réponse	1
Réponse Motrice (M)	**Score**
NORMALE : La victime répond à deux ordres simples : Ex : Ouvre la bouche et tire la langue ou serre la main par exemple	6
ÉVITEMENT ADAPTE : Réagit à la douleur en enlevant avec la main la cause de la douleur. *(Stimulus douloureux : le trapèze est pincé 10 secondes avec une intensité croissante ou pression appuyée du lit de l'ongle)*	5 
ÉVITEMENT NON ADAPTE : Flexion du membre stimulé et réaction inadaptée de l'autre membre. La victime évite le stimulus douloureux mais les mouvements sont rapides et normaux. *(stimulus douloureux : pression appuyée du lit de l'ongle ou le trapèze)*	4
FLEXION A LA STIMULATION : Flexion unilatérale ou bilatérale des membres supérieurs à la douleur. Les mouvements sont lents et stéréotypés, l'avant-bras remonte en travers du thorax en se tournant sur lui-même.	3
EXTENSION A LA DOULEUR : Réaction d'extension et rotation interne *(En tournant ses paumes vers l'extérieur)* des membres supérieurs à la douleur.	2
ABSENTE : Pas de réaction aux stimuli douloureux.	1

EXAMEN SECONDAIRE

Examen Clinique :

- Signes vitaux :
  - Fréquence cardiaque chiffrée sur 1 minute : Fréquence / Amplitude / Régularité
  - Pression artérielle
  - Fréquence respiratoire chiffrée sur 1 minute : Fréquence / Amplitude / Régularité
  - Température avec thermomètre
  - Glycémie : *si indication (< 10 ans => après avis médical)*
    - Normal à jeun : 80 à 120 mg/dl => 0.8 à 1.2 g/L
    - Hypoglycémie : Inférieure à 60 mg/dl => 0.6g/L
    - Hyperglycémie : Supérieure à 150 mg/dl => 1.5 g/L
- Examen physique focalisé ou tête-pieds (body-check) => Palpation.

Anamnèse :

O.P.Q.R.S.T. :

O : Origine des symptômes :
(1ère fois / différents ou comme d'habitude)
P : Provoqué / pallié par
Q : Qualité *(ressenti)*
R : Région / radiation
S : Sévérité (EVA)
T : Temps *(heure début / combien de temps)*

S.A.M.P.L.E.R. :

S : Signes / Symptômes
A : Allergies
M : Médicaments
P : Passé médico-chirurgical
L : Last meal = dernier repas
E : Évènement avant l'urgence
R : Facteurs à risque *(aggravant)*

F.A.S.T :

F : Face – Visage
A : Arm – Bras
S : Speech – Parole
T : Time - Temps

Valeurs normales :

	Fréquence Respiratoire	Fréquence Cardiaque	Pression Artérielle *Valeurs minimales PA Systolique*	Température
Adulte	12 à 20 / min	60 à 100 / min	100 mmHg	37,5°C
Enfant : 2 ans => puberté	20 à 30 / min	70 à 140 / min	> 10 ans : 90mmHg < 10 ans : 70 + (2 x âge)	
Nourrisson : 28 jours à 2 ans	30 à 40 / min	100 à 160 / min	70 mmHg	
Nouveau-né : < à 28 jours	40 à 60 / min	120 à 160 / min	60 mmHg	

L.A.P.S.S. : Test AVC

Interrogatoire	1 - Age > 45 ans :	☐ Oui	☐ Non
	2 - Absence d'ATCD de crises convulsives :	☐ Oui	☐ Non
	3 - Apparition des signes < 24 heures :	☐ Oui	☐ Non
	4 - Victime ambulatoire en état normal :	☐ Oui	☐ Non
Dépistage	5 - Glycémie entre 60 et 400 mg/dl :	☐ Oui	☐ Non

			GAUCHE	DROIT
Examen	Symétrie faciale à la grimace :	☐ Normal	☐ Asymétrie	☐ Asymétrie
	Serrement des mains :	☐ Normal	☐ Faible ☐ Impossible	☐ Faible ☐ Impossible
	Force des bras :	☐ Normal	☐ Affaissement ☐ Chute	☐ Affaissement ☐ Chute
	6 - Atteinte est unilatérale (pas bilatérale) :		☐ Oui	☐ Non

Si « Oui » aux 6 questions ci-dessus, alors elle doit être orientée vers un centre spécialisé après avis médical.
Attention, une victime peut avoir un AVC même si les questions ci-dessus sont négatives

ARBRE DÉCISIONNEL D'IMMOBILISATION DU RACHIS

Réponses non fiables de la victime ?

Victime dont les réponses sont qualifiées de NON fiables :

- ❑ Altération du niveau de conscience.
- ❑ Victime non coopérante, difficultés de communication.
- ❑ Influence de l'alcool ou d'autres drogues.
- ❑ Lésions qui détournent l'attention de la victime (traumatisme sévère, brûlure, etc.)
- ❑ Nombreuses lésions qui empêchent de rechercher des signes d'atteinte du rachis.

OUI

NON ↓

Présence de signes de lésion du rachis ou de la moelle ?

Signes d'atteinte du rachis :

- ❑ Douleur spontanée siégeant au niveau du rachis.
- ❑ Douleur du rachis à la mobilisation, à la marche.
- ❑ Raideur de la nuque empêchant de tourner la tête.
- ❑ Douleur à la palpation prudente du rachis.
- ❑ Déformation évidente du rachis.

Signes d'atteinte de la moelle épinière :

- ❑ Perte ou diminution de la force musculaire ou de la motricité des mains ou des pieds.
- ❑ Perte ou une diminution de la sensibilité des membres supérieurs ou inférieurs.
- ❑ Engourdissement, de sensations de décharges électriques au niveau des membres.
- ❑ Perte des urines ou des matières fécales.
- ❑ Érection chez l'homme (victime inconsciente, victime trouvée déshabillée).

OUI

NON ↓

Traumatisme à haut risque d'atteinte du rachis ?

Traumatismes à haut risque du rachis :

- ❑ Chute sur la tête d'une H > 1 mètre ou chute sur les pieds ou les fesses d'une H > 3 mètres.
- ❑ Occupant d'un véhicule accidenté à grande vitesse (voies rapides, autoroutes, vitesse > 40 km/h avec arrêt brutal contre un obstacle fixe ou sur une courte distance < 10 m, déformation de l'habitacle).
- ❑ Absence de port de ceinture de sécurité (et déclenchement des airbags).
- ❑ Retournement d'un véhicule.
- ❑ Victime éjectée d'un véhicule.
- ❑ Accidents avec des véhicules à moteur de loisirs.
- ❑ Collision avec un 2 roues (conducteur ou passager du 2 roues).
- ❑ Piéton renversé ou chute de cheval (jockey)

OUI

NON ↓

Age > 65 ans ou Antécédents à risque ?

Antécédents à risque :

- ❑ Traumatisme vertébral ancien (fracture, luxation)
- ❑ Chirurgie de la colonne vertébrale.
- ❑ Maladie de la colonne vertébrale ou des os qui qui fragilise la colonne vertébrale (ostéoporose)

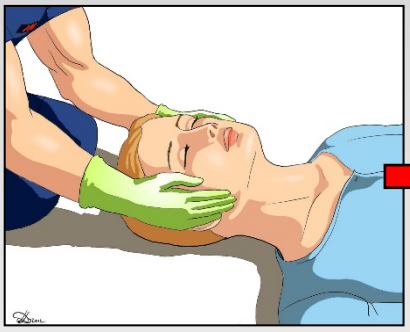
NON

OUI

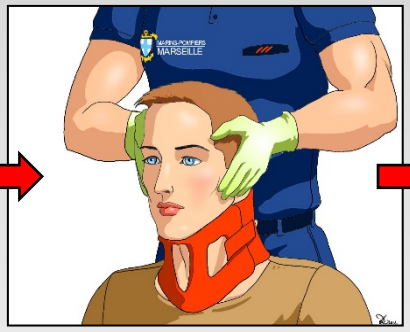
AUCUNE Immobilisation du rachis

Immobilisation du rachis

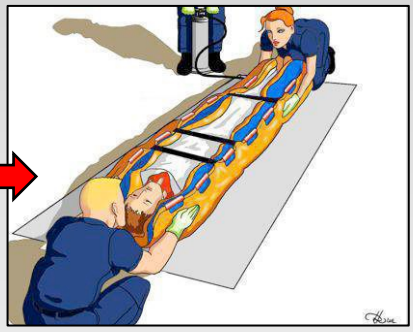
RELEVAGE & IMMOBILISATION



STABILISATION
Maintien Tête +
Demander à la victime
de ne pas bouger



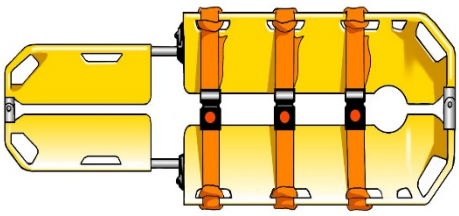
RESTRICTION CERVICALE
Attelle Cervicale
(Non systématique)
M.I.D



IMMOBILISATION
En priorité dans le MID
MID = Attelle Cervicale Desserrée.
Et resserrée pour une nouvelle
mobilisation

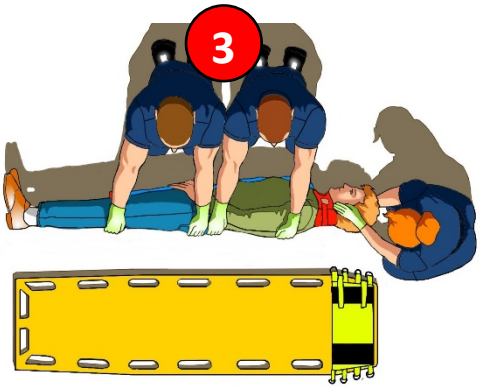
Ordre de priorité des dispositifs de relevage :

1



2

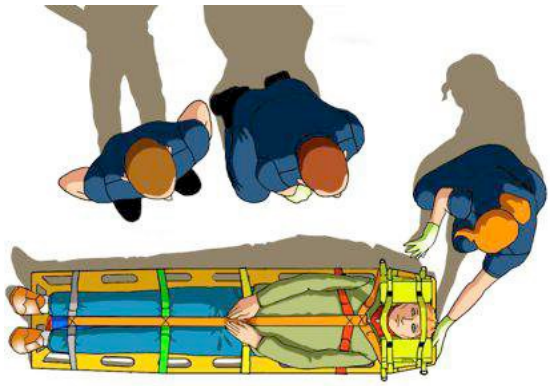
3

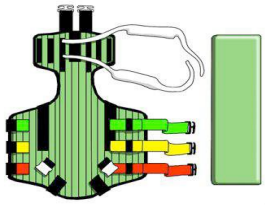


Ordre de priorité des dispositifs d'immobilisation :

1

2





A.C.T. + Attelle Cervicale à n'utiliser que pour faire des extractions *(victime située dans un endroit difficile d'accès endroit exigu, véhicule accidenté….)* **mais la desserrer après immobilisation dans le M.I.D. car elle peut entraîner des complications pulmonaires.**

MEMENTO BRÛLURES

Brûlure simple :

- Rougeurs de la peau chez l'adulte ou une cloque dont la surface est inférieure à la ½ paume de la main de la victime.

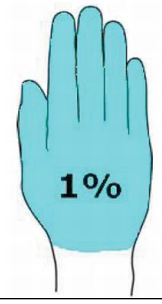
Brûlure grave :

- Une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à la ½ paume de la main de la victime.
- Destruction + profonde *(aspect blanchâtre, peau de chamois, noirâtre, indolore)* + cloques/rougeur +/- étendue.
- Aspect circulaire (tour du cou / membre)
- Localisation : Visage ou cou / Les mains / Les articulations / Voisinage des orifices naturels
- Brûlures de la bouche et du nez + raucité de la voix = DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE +++
- Brûlure d'origine électrique ou radiologique
- **Rougeur étendue *(ex : coup de soleil généralisé)* de la peau chez l'enfant**

BRÛLURES DES VOIES AÉRIENNES

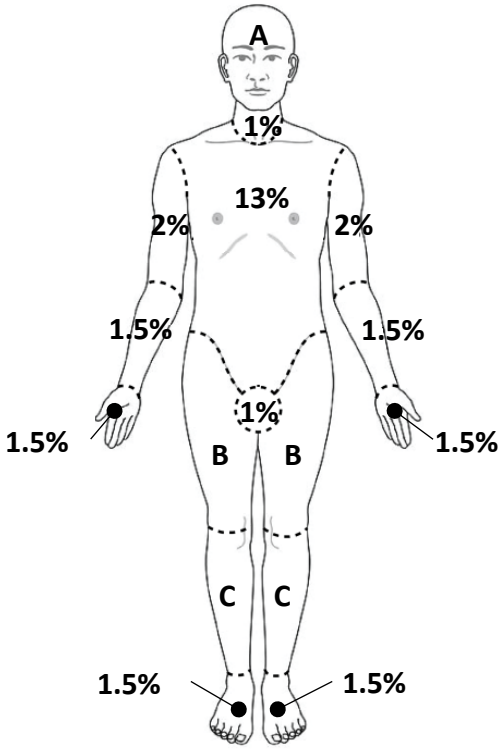
SUIES AU NIVEAU DES NARINES, DES LÈVRES, DE LA LANGUE - VOIX RAUQUE - TOUX + CRACHATS AVEC SUIES
MESURER CO - OXYGÉNER (SpO2 NON FIABLE)

PETITES SURFACES



Calcul rapide avec la paume de la main de la victime.

GRANDES SURFACES



	0 – 1 an	1 – 4 ans	5 – 9 ans	10 – 15 ans	Adulte
Tête (A)	9.5%	8.5%	6.5%	5%	3.5%
Cuisse (B)	2.75 %	3.25 %	4.25 %	4.25 %	4.75 %
Jambe (C)	2.5 %	2.5 %	2.75 %	3 %	3.5 %

REFROIDIR LA BRÛLURE GRAVE UNIQUEMENT SI :

- Victime consciente & brûlure récente : **Moins de 30 minutes**
- Et surface corporelle brûlée inférieure à :
  - 30% chez l'adulte,
  - 10% chez l'enfant,
  - 5% chez le nourrisson
- Avec de l'eau tempérée (de 15 à 25°C) ou compresses de gel d'eau *(si absence de point d'eau tempérée)*
- **ARRÊTER LE REFROIDISSEMENT AU BOUT DE 10 MINUTES MINIMUM.**
- Retirer de la zone brûlée : Vêtements non adhérents, bijoux, montre, ceinture
- Protéger la brûlure par un champ stérile.
- Envelopper la victime dans une couverture de survie stérile
- Réchauffer le brûlé : chauffage cellule VSAV & Surveiller la victime *(Température corporelle)*

MEMENTO ACCOUCHEMENT INOPINÉ

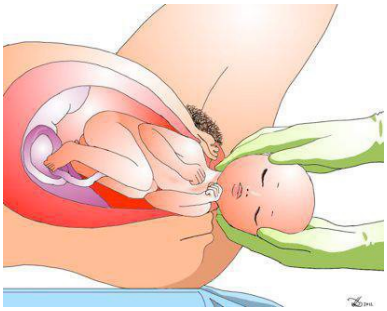
L'accouchement n'a pas encore eu lieu :

- Installer la future maman sur le côté => **INSTALLATION SUR LE DOS À PROSCRIRE**
- Recueillir les éléments suivants :
  - Suivi ou non de la grossesse / Nbre d'accouchements et de grossesses précédentes et déroulement.
  - Grossesse simple ou multiple : *(gémellaire)*
    - Type d'accouchement : voie basse / césarienne Présentation : Tête, siège, épaule et déroulement
  - L'heure de début des contractions, la durée et l'intervalle entre deux contractions
  - Si perte des eaux : heure et couleur du liquide : transparent, trouble, sanglant

SCORE DE MALINAS : Cotation =>	0	1	2
Parité	1	2	3 et +
Durée du travail	< 3h	3 à 5h	> 5h
Durée des contractions	< 1min	1 min	> 1min
Intervalle entre les contractions	> 5 min	3 à 5 min	< 3min
Perte des eaux	Non	Récente	> 1h
SCORE < à 5 = transport VSAV / SCORE > à 5 = + envie de pousser = Menace d'accouchement imminent => DDE **SMUR**.			

L'accouchement n'a pas encore eu lieu & transport impossible :

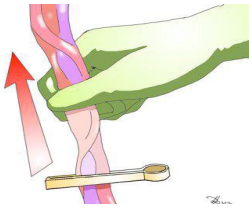
- Préparer le matériel nécessaire à l'accouchement et à l'accueil du bébé : Serviettes propres & sèches / récipient
- Matériels de réanimation du nouveau-né : Bouteille O^2 / Insufflateur Pédiatrique / Aspirateur de mucosités / Oxymètre
- Gants à usage unique & protection contre les projections de liquides.
- Installer la mère en position demi-assise, cuisses fléchies et écartées.
- Lui demander d'attraper ses cuisses avec ses mains et d'hyperfléchir ses cuisses sur l'abdomen lorsqu'elle ressent un besoin irrépressible de pousser ou si le haut du crane du bébé commence à apparaître et lui demander de pousser vers le bas en retenant sa respiration
- Faire reposer les jambes à la fin de la contraction utérine & Recommencer la même manœuvre jusqu'à l'apparition de la moitié de la tête.
- Dès lors que la moitié de la tête du bébé est apparue, cesser de la faire pousser.
- Accompagner la sortie spontanée du bébé :
  - Maintenir la tête avec les deux mains sans s'opposer à la rotation
  - Vérifier la présence ou non d'une circulaire du cordon et procéder à son dégagement si présence
  - Soutenir le corps du nouveau-né avec les mains placées sous lui
  - **NE JAMAIS TIRER SUR L'ENFANT**
- Noter l'heure de naissance & Assurer la prise en charge du nouveau-né et surveiller la mère jusqu'à la délivrance.



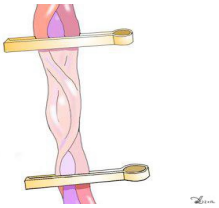
Le nouveau-né n'est pas en bonne santé si : ne respire pas/ ne crie pas / respiration anormale / hypotonique

Il faut alors : Clamper le cordon après 1 min de vie => le placer sur surface plane recouverte d'un linge => LVA tête en position neutre et si nécessaire en aspirant les mucosités.

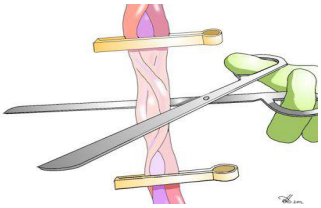
Désinfection + poser 1er clamp à 10/15cm de l'ombilic



2nd Désinfection + pincer pour vider de son sang



Placer le 2nd clamp toujours pincé à 3/5 cm du 1er



Couper le cordon entre les 2 clamps puis recouvrir avec compresse stérile

Si état inchangé : 40 insufflations à l'air en 1 minute, si thorax ne se soulève après les 5 insufflations vérifier LVA

L'état du nouveau-né reste inchangé : RCP 3/1 à une fréquence 120mvt/min + apport d'O^2 et **SANS POSE DE DSA**

RÉÉVALUER L'ÉTAT DU NOUVEAU-NÉ TOUTES LES MINUTES

FRÉQUENCE CARDIAQUE	PROCÉDURE
Inférieur à 60 battements/min :	RCP 3/1 fréquence 120 mvt/min + apport d'O^2 et SANS POSE DSA
60 à 100 battements/min :	Insufflation à l'air SANS compressions thoraciques
Supérieure 100 battements/min :	Surveiller étroitement le nouveau-né

SDIS 25 DOUBS	**FICHE MÉMO** **TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX**	Mis à jour : Avril 2019 SGT PERRIGUEY

- Aciclovir : antiviral
- Acide alendronique : FOSAMAX, ttt ostéoporose
- Acide folique : Vit B9, ttt anémie
- Acupan : antalgique palier 1
- Aldactazine : ttt anti-HTA, œdèmes insuffisance hépatique, cardiaque
- Aldactone : diurétique
- Alprazolam : anxiolytique
- Altéis : anti-HTA
- Amlodipine : inhibiteur calcique, anti-HTA
- Amoxicilline : ATB (pénicilline)
- Aotal : ttt sevrage OH symptôme de manque
- Aprovel : anti-HTA
- Artane : antiparkinsonien
- Atarax : anxiolytique et antihistaminique
- Aténolol : bétabloquant, anti-HTA
- Atorvastatine : hypolipidémiant (ttt cholestérol)
- Baclofène : myorelaxant
- Bactrim : ATB
- Bétahistine : antivertigineux
- Bisoprolol : bétabloquant
- Brilique : antiagrégant plaquettaire
- Burinex : diurétique, ttt insuffisance cardiaque, rénale, œdèmes
- Candésartan : anti-HTA
- Carbamazépine : antiépileptique, thymorégulateur
- Céfixime : ATB - Cefpodoxime : ATB
- Céliprolol : bétabloquant, anti-HTA
- Céris : antispasmodique urinaire
- Cétirizine : antihistaminique
- Ciprofloxacine : ATB
- Citalopram : antidépresseur
- Clomipramine : antidépresseur
- Clopidogrel : PLAVIX : antiagrégant plaquettaire
- Coaprovel : anti-HTA
- Colchicine/Colchimax : antigoutteux
- Contramal : antalgique palier 2
- Cordarone : Anti-arythmique
- Corvasal : vasodilatateur (angine de poitrine)
- Crestor : hypolipémiant (ttt cholestérol)
- Dépakote/Dépamide : thymorégulateur
- Diffu-K : potassium
- Digoxine : ttt insuffisance cardiaque, tachycardie
- Dompéridone : antiémétique
- Donépézil : ttt maladie d'Alzheimer
- Eliquis : anticoagulant (NACO)
- Emend : antiémétique
- Enalipril : anti-HTA
- Esidrex : diurétique
- Euphylline : antiasthmatique
- Ezetrol : hypolipémiant (ttt cholestérol)
- Flagyl : ATB et antiparasitaire
- Flécaïne : antiarythmique
- Fluconazole : antifongique
- Fludex : anti-HTA
- Fluoxétine : antidépresseur
- Fosavance : Vit D, ttt ostéoporose
- Fumafer : fer
- Furadantine : ATB
- Gabapantine : antiépileptique
- Gliclazide : antidiabétique oral (ADO)
- Glimépiride : antidiabétique oral (ADO)
- Glucor : antidiabétique oral (ADO)
- Haldol : neuroleptique
- Havlane : hypnotique
- Hémi-Daonil : antidiabétique oral (ADO)
- Hemigoxine : ttt insuffisance cardiaque, tachycardie
- Heptaminol : ttt hypotension orthostatique
- Hyperium : anti-HTA
- Ibuprofène : AINS
- Isoptine : vasodilatateur, anti-HTA, tb du rythme
- Inexium : protecteur gastrique
- Izilox : ATB
- Januvia : antidiabétique oral (ADO)
- Kétoprofène : AINS
- Lamaline : antalgique palier 2
- Lamotrigine : antiépileptique
- Largactil : neuroleptique
- Lasilix : diurétique
- Lepticur : antiparkinsonien
- Lercanidipine : anti-HTA
- Lévétiracétam : KEPPRA : antiépileptique
- Lévothyrox : hormone thyroïdienne
- Lexomil : anxiolytique
- Lipanthyl : hypolipémiant (ttt cholestérol)
- Lopéramide : antidiarrhéique
- Loxen : anti-HTA
- Lyrica : antiépileptique (+ douleurs neuropathiques)
- Lysanxia : anxiolytique
- Mémantine : ttt maladie d'Alzheimer
- Metformine : antidiabétique oral (ADO)
- Méthadone : ttt de manque des toxicomanes
- Miansérine : antidépresseur

- Minisintrom : anticoagulant (AVK)
- Mirtazapine : antidépresseur
- Modopar : antiparkinsonien
- Montelukast : antiasthmatique
- Nebivolol : bétabloquant
- Nicorandil : vasodilatateur (angine de poitrine)
- Nifluril : AINS
- Ofloxacine : ATB
- Olanzapine : neuroleptique
- Oxéol : bronchodilatateur (ttt asthme, BPCO)
- Oracilline : ATB - Orbénine : ATB
- Pantoprazole : protecteur gastrique
- Parkinane : antiparkinsonien
- Paroxétine : antidépresseur
- Périndopril : anti-HTA, ttt insuffisance cardiaque
- Phloroglucinol : SPASFON : antispasmodique
- Pradaxa : anticoagulant (NACO)
- Prednisone : cortisone (AIS)
- Préviscan : anticoagulant (AVK)
- Primpéran : antiémétique
- Procolaran : vasodilatateur (angine de poitrine)
- Propanolol : bétabloquant, anti-HTA, tb du rythme
- Pyostacine : ATB
- Ramipril : anti-HTA, ttt insuffisance cardiaque
- Repaglinide : antidiabétique oral (ADO)
- Risperdal : neuroleptique
- Rovamycine : ATB - Roxithromycine : ATB
- Sectral : bétabloquant, anti-HTA, tb du rythme
- Seresta : anxiolytique
- Seroplex : antidépresseur
- Setraline : antidépresseur
- Simvastatine : hypolipémiant (ttt cholestérol)
- Sintrom : anticoagulant (AVK)
- Solian : neuroleptique
- Solupred : cortisone (AIS)
- Sotalol : bétabloquant, antiarythmique
- Stablon : antidépresseur
- Stresam : anxiolytique
- Subutex : ttt de manque des toxicomanes
- Surfarlem : correcteur insuffisance salivaire
- Tamoxifène : ttt cancer du sein
- Tanganil : antivertigineux
- Tégrétol : antiépileptique
- Temesta : anxiolytique
- Tenstaten : anti-HTA
- Tercian : neuroleptique
- Tiapridal : neuroleptique
- Tiorfan : antidiarrhéique
- Tramadol : antalgique palier 2
- Tranxène : anxiolytique
- Trimébutine : antispasmodique
- Trivastal : antiparkinsonien
- Urbanyl : anxiolytique
- Valaciclovir : antiviral
- Valium : anxiolytique (convulsions chez l'enfant)
- Valproate de sodium : antiépileptique
- Valsartan : anti-HTA
- Venlafaxine : antidépresseur
- Vogalène : antiémétique
- Xarelto : anticoagulant (NACO)
- Xatral : ttt hypertrophie bégnine de la prostate
- Zolpidem : hypnotique
- Zophren : antiémétique
- Zopiclone : hypnotique
- Zyloric : antigoutteux

VALEURS DE RÉFÉRENCE

INR	**Cible :** entre 2 et 3 (chez les victimes sous AVK)	Surveillance biologique des patients sous AVK *INR à 1 chez l'individu sain*
Glycémie	**A jeun :** entre 0,8 et 1,2 g/L **Hypoglycémie :** glycémie < 0,6 g/L **Hyperglycémie :** glycémie > 1,5 g/L	Taux ou concentration de sucre (glucose) dans le sang

ABRÉVIATIONS

AIS/AINS	Anti-Inflammatoire Stéroïdien/Non Stéroïdien	**DNID**	Diabète Non Insulino-Dépendant
ATB	Antibiotique	**HTA**	Hyper-Tension Artérielle
AVK	Anti-Vitamine K	**NACO**	Nouveaux Anti-Coagulant Oraux
BPCO	Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive	**ttt**	Traitement
DID	Diabète Insulino-Dépendant		

Morphologie	Age	Fréquence cardiaque *Battements/min*	Fréquence ventilatoire *mouvements/min*	Débit inhalation & insufflation	Fréquence RCP en équipe	DAE
Adulte	Sup puberté / corpulence	60 à 100	12 à 20	**<u>INSUFFLATION</u>** 15 litres/minute, dès que la mesure SpO^2 peut être mesurée, ajuster le débit en oxygène. **<u>INHALATION</u>** <u>Débit initial MHC :</u> 15 litres/minute. • Plage de réglage : 8 à 15 L/min <u>Débit initial MMC :</u> 10 litres/minute. • Plage de réglage : 6 à 10 L/min <u>Lunettes à O^2 :</u> 2 L/min *(1 à 2 L/min de + / débit habituel)* • Plage de réglage : 1 à 6 L/min **<u>OBJECTIF DE SATURATION</u>** 94% à 98% : Adulte & Pédiatrie. 89% à 92% : Insuffisant Respiratoire Chronique	30 massages / 2 insufflations Fréquence = 100 à 120/minute Compressions ≈ 5cm, sans dépasser 6 cm	OUI
Enfant	Inf puberté /corpulence	70 à 140	20 à 30		5 Insufflations initiales + RCP 15/2 Fréquence = 100 à 120/minute Compressions : 1/3 ou ≈ 5 cm	OUI
Nourrisson	Jusqu'à 2 ans	100 à 160	30 à 40		5 Insufflations initiales + RCP 15/2 Fréquence = 100 à 120/minute Compressions : 1/3 ou ≈ 4 cm	OUI
Nouveau-né	1 à 28 jours	120 à 160	40 à 60		5 Insufflations initiales + RCP 15/2 Fréquence = 120/minute Compressions : 1/3 ou ≈ 4 cm	OUI
CAS PARTICULIER NOUVEAU-NE A LA NAISSANCE						
Nouveau-né à la naissance	1ère heures de vie	120 à 160	40 à 60	**<u>Nouveau-né n'est pas en bonne santé si :</u>** Ne respire pas ; ne crie pas ; présente une respiration anormale ; hypotonique **<u>1ère étape :</u>** clamper le cordon après 1 minute de vie. **<u>2ème étape :</u>** LVA en position neutre + aspiration mucosités **<u>Si son état est inchangé :</u>** 40 insufflations à l'air en 1 minute Vérifier LVA et étanchéité du masque sur les 5 premières insufflations. **<u>3ème étape :</u>** réévaluer l'état du nouveau-né après 1 minute, si l'état reste inchangé : **RCP 3/1 avec O^2 SANS POSE DE DAE**	**<u>FC < à 60 battements/minute :</u>** RCP : 3 massages/1 insufflation avec O^2 Fréquence = 120/minute **Réévaluer FC toutes les minutes**	**NON**
					<u>FC entre 60 et 100 battements /min :</u> Insufflations à l'air sans compression thoracique **Réévaluer FC toutes les minutes**	**NON**
					<u>FC > supérieure à 100 battements/min :</u> Surveiller étroitement le nouveau-né. **Réévaluer FC toutes les minutes**	**NON**
Cas particulier : L'hypothermie inférieure à 30°C				Pas plus de 3 chocs tant que la victime n'est pas réchauffée.		
Cas particulier : La noyade				Commencer par 5 insufflations		

EVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

« Ces visages montrent combien on peut avoir mal.

Ce visage *(montrer celui de gauche)* **montre quelqu'un qui n'a pas mal du tout.**

Ces visages *(les montrer un à un de gauche à droite)* **montrent quelqu'un qui a de plus en plus mal, jusqu'à celui-ci** *(montrer celui de droite)***, qui montre quelqu'un qui a très très mal. »**

Montre-moi le visage qui montre combien tu as mal en ce moment.

Les scores sont de gauche à droite : 0, 2, 4, 6, 8, 10.

Exprimez clairement les limites extrêmes : « pas mal du tout » et « très très mal ». N'utilisez pas les mots « triste » ou « heureux ».

Précisez bien qu'il s'agit de la sensation intérieure, pas de l'aspect de leur visage.

NORMES PEDIATRIQUES

AGE	Nné	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	≥ 14 ans
F. Resp / min	30 – 60	30 – 60	30 – 60	30 – 60	24 - 40	20 - 40	22 - 34	18 – 30	18 - 30	12 – 16
F. Card / min	85 – 205	85 – 205	100 – 190	100 – 190	100 – 190	60 - 140	60 - 140	60 – 140	60 - 140	60 – 140
TA Systolique (mmHg)	60 – 94	78 – 103	82 - 105	90 mmHg + (2 x âge en années)						110 – 130
HYPOTENSION (TAS)	**< 60**	**< 70**	**> 70**	**70 mmHg + (2 x âge en années)**						**< 90**

SCORE D'APGAR

Fréquence cardiaque	Mvts respiratoires	Tonus musculaire	Réactivité	Coloration	Cotation
Absence	Absents	Flasque	Pas de réponse	Cyanose pâleur	**0**
< 100 / min	Irréguliers	En flexion léger	Légers mvts	Extrémités cyanosées	**1**
> 100 / min	Réguliers	En flexion bon	Cri	Rose	**2**

Si < 10 il sera réévalué à 3 – 5 et 10 minutes

Le nouveau-né normal a un score d'Apgar ≥ 7

REGIONS ANATOMIQUES	ELEMENTS DE BASE	ELEMENTS COMPLEMENTAIRES
Visage / face	Tuméfactions Lacérations Contusions Déformation Asymétrie Brûlures	Emphysème sous-cutané Liquides
Yeux	Corps étrangers Pupilles : taille / réactivité / isocorie	Lentilles de contact Paupières et pourtour de l'œil Trouble visuel (flou, diplopie, etc.) Écoulement
Nez	Écoulement de sang Déviation cloison nasale Battements des ailes du nez	Mucus
Oreilles	Écoulements de LCR Écoulement de sang Ecchymose	Signe de Battle = Ecchymose derrière l'oreille due à une fracture du rocher.
Bouche / gorge	Hémorragies Muqueuses Œdème Cyanose Morsure de langue Corps étrangers Haleine Brûlures Prothèses dentaires	Dentition gâtée Dents branlantes Déviation luette Suie
Cou / nuque	Douleur Utilisation muscles accessoires Déviation de la trachée Emphysème sous-cutané Ecchymose Plaies / Lacérations Brûlures	Ganglions
Thorax	Ecchymose Tuméfaction Asymétrie ventilatoire Volet thoracique Utilisation muscles accessoires Dispositifs médicaux (pace maker, cathéters, patch médicamenteux) Cicatrices Brûlures Plaie pénétrante Plaie soufflante	Forme du thorax Emphysème sous-cutané
Abdomen	Ecchymoses Lacérations Distension Défense Éviscérations Traces d'injections Dispositifs médicaux (pompe à insuline, stomie, etc.) Cicatrices Brûlures	Masses pulsatiles Pouls fémoraux Hernie Balance thoraco abdominale

Bassin	Douleur Hématome	
Dos/colonne	Douleur Déformation Ecchymose Perforation Plaie soufflante Asymétrie ventilatoire Volet thoracique Cicatrices Brûlures	Emphysème sous-cutané Courbure rachidienne
Organes génitaux / Anus	Perte d'urine Perte sanguine Écoulement Masse Sonde urinaire Incontinence	Inflammation Éruptions Liquide amniotique Apparition de la tête, d'un membre ou cordon du fœtus
Extrémités	Crépitements osseux Inflammation Asymétrie Lacérations Ecchymoses Déformations Œdèmes Traces d'Injections Bracelets médicaux Fonctions motrices et sensitives Pouls distaux Paresthésie Cicatrices Brûlures	Amplitude articulaire Rougeur Chaleur accrue Atrophie Ganglions Dilatation veineuse Ataxie = trouble de la coordination, d'origine neurologique. Pouls paradoxaux Pression différentielle
Peau / ongles / cheveux	Cicatrices Couleur Chaleur Humidité (sèche, diaphorétique, pli cutané) Tuméfactions, lésions Brûlures Trace d'injection Cicatrices	Plaies d'escarres Perte ou croissance anormale de cheveux Stries, couleur et épaisseurs des ongles Pétéchies = tache rouge / violacée ne blanchissant pas sous la pression Zone de décoloration Ictère = jaunisse